الدليل 2 / 5

دليل التثبيت التقويمي

أسباب الانتكاس، واختيار جهاز التثبيت المناسب، وجدول المراجعات، والتعامل مع انفصال المثبّت ومع الانتكاس. مع نص توعوي جاهز لتسليمه للمريض.

المحتويات

1 · لماذا يحدث الانتكاس؟

2 · المثبّت اللساني الثابت: 3-3 و2-2

3 · المثبّت اللساني الثابت: السلك واللصق والإخفاقات

4 · التثبيت المتحرك: Essixg Hawley (الجبيرة الشفافة)

5 · اختيار التثبيت حسب نوع الحالة

6 · بروتوكول الارتداء وجدول المراجعات

7 · التعامل مع الكسر والانفصال

8 · الانتكاس: التعرّف والتدخل

9 · قائمة التحقق عند تسليم الجهاز

10 · نشرة المريض (نص للتسليم)

الخطوة التالية

الفصل 1

لماذا يحدث الانتكاس؟

بعد هذا الفصل ستتمكن في كل حالة من تقدير خطر الانتكاس قبل إزالة الحاصرات.

الأسنان لا تكون قد «استقرت» بعد في نهاية العلاج. فالنسج حول السنية والأنسجة الرخوة والنمو تواصل سحبها نحو وضعها السابق. والتثبيت هو الرد على هذه القوى.

مصدر الانتكاس	ماذا يحدث؟	نصيحة سريرية
الألياف اللثوية وفوق السنخية	في الدورانات المصحّحة تبقى الألياف مشدودة وتعيد تدوير السن.	الأسنان شديدة الدوران في البداية هي الفئة الأعلى خطورة.
إعادة التشكّل حول السنية	تبقى السن متحركة إلى أن يتكيف العظم والرباط حول السني (PDL) مع الوضع الجديد.	الفترة الأولى بعد الإزالة هي الأكثر حرجًا.
توازن الأنسجة الرخوة	قوى الشفة والخد واللسان تدفع السن عائدة إلى منطقة التوازن.	إذا أبرزت القواطع السفلية بدرجة كبيرة فالخطر مرتفع.
تغيّر شكل القوس	العرض بين النابين السفليين خاصةً يميل إلى العودة لقيمته قبل العلاج.	حافظ على المسافة بين النابين السفليين قدر الإمكان.
النمو المتبقي	النمو المتأخر للفك السفلي قد يزيد ميول الصنف الثالث والازدحام السفلي.	خطط لتثبيت طويل لدى مريض الصنف الثالث الذي ما زال في طور النمو.
العادات	إذا استمر دفع اللسان أو مص الإصبع أو عض الشفة تعود العضة المفتوحة والبروز.	لا تُزل الجهاز قبل زوال العادة.
الإنهاء غير المكتمل	إذا لم يستقر الإطباق ولم يكن العزم وتوازي الجذور مناسبين تنزاح الأسنان.	أجرِ فحوص الإنهاء في الوحدة 08 قبل الإزالة.

حالات البدء عالية الخطورة

سهميًا وعموديًا

- العضة العميقة (خاصةً الصنف الثاني القسم 2)
- العضة المفتوحة الأمامية ودفع اللسان
- الصنف الثالث في طور النمو
- خلل هيكلي صُحّح بالتمويه التقويمي

على مستوى الأسنان

- دورانات واضحة
- الفراغ بين القاطعتين المركزيتين (الدياستيما)، ولجام سميك
- ازدحام شديد في البداية
- أسنان بزغت في موضع منتبذ ثم رُتّبت لاحقًا

خطأ شائع

اعتبار التثبيت «الزيارة الأخيرة» في العلاج. اكتب خطة التثبيت مع خطة العلاج منذ الزيارة الأولى، واشرحها للمريض من البداية.

قاعدة عملية

استخدم هذه الجملة عند الموافقة على العلاج: «ستميل أسنانك إلى الحركة طوال حياتك. والتثبيت هو الطريقة التي نتحكم بها في هذه الحركة.»

الفصل 2

المثبّت اللساني الثابت: 3-3 و2-2

حدّد الأسنان التي ستثبّته عليها بناءً على خطورة الحالة ونظافة الفم.

المثبّت اللساني الثابت لا يعتمد على تعاون المريض (compliance)، لذلك يُختار غالبًا في المنطقة الأمامية، وخاصةً في الفك السفلي. وثمنه العناية بنظافة الفم والمراجعة المنتظمة.

3-3 (من الناب إلى الناب، مع النابين)

- الأسنان الأمامية الستة كلها مثبّتة.
- الخيار الكلاسيكي في الفك السفلي: يثبّت النابين والقواطع معًا.
- أكثر أمانًا في حالات دوران الناب أو ازدحام النابين أو حالات الخلع.
- إذا كان الناب السفلي يلامس الأنياب العلوية فالتحقق من التداخل الإطباقي إلزامي.

2-2 (القواطع فقط)

- القواطع الأربع مثبّتة، والنابان حرّان.
- خيار شائع في الفك العلوي: يؤثر أقل في التوجيه الناب وفي الإطباق.
- قد يكفي عند إغلاق الدياستيما وفي دورانات القواطع.
- لأن النابين يبقيان حرّين، قد يحدث انتكاس في منطقة الناب.

خيارات أخرى

النوع	متى؟	انتبه
مثبّت طويل ملصق على كل الأسنان	إغلاق فراغات يمتد حتى منطقة الضواحك، أو فقدان الارتباط حول السني.	نظافة الفم أصعب؛ خطط له برأي اختصاصي.
مزيج ثابت + متحرك	الحالات عالية الخطورة: مثبّت لساني ثابت + Essix أو Hawley ليلًا.	يجب ألا يضغط الجهاز المتحرك على السلك الثابت.

هل كان في الفك السفلي دوران في الناب أو ازدحام في منطقة الناب؟

↓

نعم ← مثبّت لساني ثابت 3-3. تحقق من التماس الإطباقي للنابين ومن التداخل.

لا ← 3-3 أو 2-2 حسب نظافة الفم وتفضيل المريض. في الفك العلوي عادةً 2-2.

خطأ شائع

وضع الكمبوزيت في الفك العلوي على النقطة التي تعضّ عليها القواطع السفلية. عندما يُطبق المريض يصطدم الكمبوزيت وينفصل السلك. حدّد نقاط التماس بورق العض قبل اللصق.

الفصل 3

المثبّت اللساني الثابت: السلك واللصق والإخفاقات

سلك خامل وحقل عمل جاف: شرطا النجاح.

اختيار السلك

السلك	الميزة	العيب
متعدد الجدائل، مجدول (دائري)	مرن، يسمح بالحركة الفيزيولوجية للأسنان؛ يلتصق جيدًا بالكمبوزيت.	قد ينفك أو ينكسر مع الوقت؛ وإذا تشوه قد يصبح فعّالًا.
مجدول مستطيل / من نوع الشريط	يتكيف جيدًا مع سطح السن، ويقاوم الدوران داخل الكمبوزيت.	أكثر صلابة؛ يجب أن يكون التكييف دقيقًا.
فولاذ أملس أحادي الجديلة	مقاوم للكسر، سهل التنظيف.	صلب؛ يُلصق عادةً على السنين الطرفيين فقط، وقد تبقى الأسنان الوسطى حرّة.
سلك مثني في المختبر أو رقميًا	الملاءمة الخاملة أكثر قابلية للتوقع.	مرحلة عمل وتكلفة إضافيتان؛ يجب أن يكون النموذج أو المسح دقيقًا.

اللصق خطوة بخطوة

1. **التنظيف** — نظّف الأسطح اللسانية بمعجون التلميع؛ وأزل القلح قبل ذلك.
2. **العزل** — مبعد للخد واللسان، وماصّة لعاب، ولفافات قطن. التلوث في المنطقة اللسانية السفلية هو السبب الأول للإخفاق.
3. **تجربة السلك** — جرّب السلك في مكانه قبل اللصق. يجب ألا يضغط على أي سن وألا يلامس اللثة.
4. **التخريش والربط** — اتبع تعليمات الشركة المصنعة؛ ولا تلوّث السطح المخرّش مجددًا.
5. **ثبّت السلك** — أمسك السلك في وضع خامل بخيط الأسنان أو بماسك السلك أو بقالب توضيع.
6. **الكمبوزيت** — على كل سن كمبوزيت يحيط بالسلك تمامًا بحواف ملساء. اترك المناطق الملاصقة مفتوحة للتنظيف.
7. **التصليب والإنهاء** — أزل الفائض، ومرّر خيط الأسنان في المناطق الملاصقة، وتحقق من الإطباق.

أنواع الإخفاق

النوع	السبب المحتمل	الوقاية
انفصال الكمبوزيت عن السن	تلوث، تخريش غير كافٍ.	عزل أفضل، حقل عمل جاف.
انفصال السلك عن الكمبوزيت	كمبوزيت قليل، بقي السلك على السطح.	كمية كمبوزيت تحيط بالسلك تمامًا.
كسر السلك	إجهاد المعدن، طعام قاسٍ، تماس إطباقي.	ضبط الإطباق، توعية المريض.
حركة سنية غير مرغوبة	سلك فعّال (مشوّه أو مشدود)؛ يطبّق عزمًا أو دورانًا على السن.	سلك خامل، استبدال السلك المشوّه، مراجعة منتظمة.

لا تغفل عن هذا

حتى السلك اللساني الذي يبدو سليمًا قد يحرّك الأسنان. في المراجعات لا تسأل فقط «هل انفصل شيء؟» بل أيضًا «هل تحافظ الأسنان على وضعها؟». إذا رأيت عزمًا غير متوقع في القواطع أو اختلافًا في مستوى الأنياب أو انحسارًا لثويًا فاعتبر السلك فعّالًا.

الفصل 4

التثبيت المتحرك: Essixg Hawley

خياران كلاسيكيان يعتمدان على تعاون المريض. اعرف متى يكون كل منهما أفضل.

Hawley

- صفيحة أكريلية حنكية/لسانية، وقوس شفوي، ومشابك على الأرحاء. أضعف من الناحية الجمالية والنطق.
- يسمح بالاستقرار العمودي للأسنان الخلفية (لا يغطي الأسطح الإطباقية).
- قابل للتعديل لتصحيحات بسيطة؛ ويمكن إضافة مستوى عض أمامي (صفيحة عض).
- إذا مرّ القوس الشفوي من الجهة الوحشية للناب فقد يفتح فراغًا؛ انتبه لذلك.

Essix (الجبيرة الشفافة)

- جبيرة شفافة مشكّلة حراريًا تغطي جميع الأسنان.
- جمالية، سريعة ورخيصة التصنيع؛ تتآكل بسرعة مع صرير الأسنان.
- تحافظ جيدًا على تصحيح الدورانات الأمامية وانتظام الأسنان.
- تغطي الأسطح الإطباقية: تحدّ من الاستقرار العمودي.
- تتآكل وتتشقق ويتغير لونها؛ تحتاج إلى استبدال دوري.
- **خطأ شائع:** ترك حواف حادة. دوّر الحواف ولا تهيّج الحليمات.

الحالة	الأنسب	لماذا
عضة مفتوحة مصحّحة	**Hawley** (ويمكن مع شبكة لسان)	التغطية الإطباقية قد تؤثر في البثق الخلفي والاستقرار؛ والتحكم في العادة ضروري.
عضة عميقة مصحّحة	**Hawley + مستوى عض أمامي**	تماس القواطع السفلية مع المستوى يحدّ من انتكاس العضة العميقة.
دورانات واضحة، بالغ بمتطلبات جمالية عالية	**Essix** (ويمكن مع مثبّت لساني ثابت)	التغطية الكاملة تحافظ جيدًا على تصحيح الدوران.
أُجري توسيع عرضي	**Hawley يغطي الحنك** أو جبيرة صلبة	الصفيحة الأكريلية تقاوم الانتكاس العرضي.

قاعدة عملية

سلّم الجهاز المتحرك يوم إزالة الحاصرات أو بعده مباشرة. كل يوم يمر بينهما نافذة للانتكاس. خذ طبعة/مسحًا قبل الإزالة، وليكن الجهاز جاهزًا.

الفصل 5

اختيار التثبيت حسب نوع الحالة

انظر إلى المشكلة الأولية وقرّر الجهاز والمدة في دقيقتين.

المشكلة الأولية	الفك العلوي	الفك السفلي	ملاحظة
ازدحام أمامي سفلي	Essix أو Hawley	مثبّت لساني ثابت 3-3	أكثر استقرارًا إذا حوفظ على العرض بين النابين السفليين.
الفراغ بين القاطعتين المركزيتين (الدياستيما)	مثبّت لساني ثابت 2-2 أو 1-1 + جهاز متحرك ليلًا	حسب الحاجة	في حال اللجام السميك اطلب رأيًا جراحيًا.
دوران واضح	مثبّت لساني ثابت + Essix	مثبّت لساني ثابت	قد يُطلب رأي اختصاصي اللثة لجراحة الألياف فوق السنخية.
العضة العميقة	Hawley + مستوى عض أمامي	مثبّت لساني ثابت 3-3	أطِل مدة الارتداء الليلي.
العضة المفتوحة	Hawley (مع شبكة لسان عند الحاجة)	مثبّت لساني ثابت أو Hawley	متابعة العادة ووضع اللسان.
العضة المعكوسة الخلفية (توسيع)	Hawley يغطي الحنك أو جبيرة صلبة	حسب الحاجة	الانتكاس العرضي يظهر مبكرًا.
تصحيح الصنف الثاني	Hawley أو Essix؛ وعند الحاجة جهاز وظيفي ليلًا	مثبّت لساني ثابت 3-3	إذا وُجد نمو فيجب متابعة الانتكاس السهمي.
الصنف الثالث، والنمو مستمر	Hawley أو Essix	مثبّت لساني ثابت 3-3	متابعة طويلة حتى انتهاء النمو؛ ويجب إبلاغ الأسرة.
حالة خلع	Essix أو Hawley	مثبّت لساني ثابت 3-3	انتبه لانفتاح فراغات الخلع.
بالغ لديه فقدان ارتباط حول سني	مثبّت لساني ثابت طويل	مثبّت لساني ثابت طويل	متابعة مشتركة مع اختصاصي اللثة؛ تثبيت غير محدد المدة.

هل سيرتدي المريض الجهاز المتحرك بانتظام؟ (العمر، الدافع، التعاون السابق)

↓

نعم ← جهاز متحرك حسب نوع المشكلة؛ وفي الخطورة العالية أضف مثبّتًا لسانيًا ثابتًا.

لا ← المثبّت اللساني الثابت إلزامي في المناطق الخطرة؛ وأعطِ الجهاز المتحرك «كضمان إضافي».

عن المدة

لا توجد إجابة واحدة صحيحة لمدة التثبيت. النهج الحالي أن تخبر المريض منذ البداية: في كل حالة يكون الاستقرار فيها هو الهدف، يكون التثبيت طويل الأمد، وكثيرًا ما يكون غير محدد المدة.

الفصل 6

بروتوكول الارتداء وجدول المراجعات

أرفق مدة الارتداء ومواعيد المراجعات كتابيًا بملف المريض.

نموذج إطار الارتداء (جهاز متحرك)

الفترة	الارتداء	ما يتحقق منه الطبيب
الفترة الأولى بعد الإزالة	طوال اليوم، باستثناء الأكل وتنظيف الأسنان (للمدة التي يحددها الطبيب).	الملاءمة، الألم، النطق، الاستقرار.
الفترة الانتقالية	بموافقة الطبيب: ليلًا + جزءًا من النهار.	انفتاح الفراغات، عودة الدوران.
الفترة طويلة الأمد	كل ليلة.	تآكل الجهاز، الإحساس بالشد.
الفترة طويلة الأمد جدًا	حسب قرار الطبيب: كل ليلة أو في ليالٍ معينة من الأسبوع.	إذا ظهر إحساس بأنه «يضغط» فزِد عدد مرات الارتداء.

هذا الجدول مجرد إطار. أنت من يحدد المدد حسب خطورة الحالة، وتدوّنها في ملف المريض.

تسلسل زيارة المراجعة

1. **السؤال عن التاريخ** — كم مرة يرتديه؟ هل يضغط؟ هل لاحظ انفصالًا أو كسرًا؟
2. **المثبّت اللساني الثابت** — افحص كل نقطة كمبوزيت بالمسبر؛ هل يوجد فراغ بين السلك والكمبوزيت؟
3. **وضع الأسنان** — الدوران، الفراغ، عزم القواطع، مستوى الأنياب. قارن بالصورة أو النموذج المسجّل.
4. **الجهاز المتحرك** — الاستقرار، التشقق، التآكل، ثبات المشابك، النظافة.
5. **النسج حول السنية** — القلح، النزف، الانحسار اللثوي (خاصةً عند القواطع السفلية).
6. **الإطباق** — تداخل الجهاز أو الكمبوزيت عند الإطباق.
7. **التوثيق** — سجّل الموجودات وموعد الزيارة التالية.

جدول المراجعات (قابل للتعبئة)

تاريخ الإزالة

جهاز الفك العلوي

جهاز الفك السفلي

المراجعة 1

المراجعة 2

المراجعة 3

المراجعة السنوية

استبدال الجهاز المتحرك

خطأ شائع

أن تصرف المريض بعد الإزالة بعبارة «إن حدثت مشكلة فعُد إلينا». المريض في أغلب الأحيان لا يلاحظ الانتكاس؛ وحين يلاحظه تكون المشكلة قد كبرت. حدّد موعد المراجعة الأولى يوم الإزالة.

الفصل 7

التعامل مع الكسر والانفصال

اعرف بوضوح ما ستفعله عندما يقول المريض: «انفصل السلك».

كم نقطة انفصلت، وهل تحركت السن؟

↓

نقطة واحدة، والسن في مكانها ← نظّف المنطقة، وتأكد من الوضع الخامل للسلك، وأعد لصق النقطة نفسها.

عدة نقاط، أو انزاحت السن ← قدّر أولًا هل يلزم تصحيح السن. استبدل السلك؛ وعند الحاجة أجرِ تصحيحًا قصيرًا.

هل تنفصل النقطة نفسها مرارًا؟

↓

نعم ← افحص التماس الإطباقي وخمول السلك والعزل. أعد تكييف السلك أو اصنع سلكًا جديدًا.

لا ← تكفي إعادة اللصق. كرّر للمريض التحذير الخاص بالأطعمة القاسية.

قبل أن يتصل: القاعدة التي تعطيها للمريض

- إذا انفصل السلك، احجز موعدًا في أقرب وقت.
- إذا كان لديك جهاز متحرك، ارتدِه طوال اليوم حتى الزيارة. لا تثنِ السلك بنفسك؛ وإذا كان يخز فضع عليه شمع التقويم.

الحالة	فورًا	بعد ذلك
انكسر السلك وأطرافه تخز	سوِّ الأطراف أو أزل القطعة المكسورة	سلك جديد؛ وجهاز متحرك في الأثناء
السلك سليم لكن السن تحركت	اعتبر السلك فعّالًا واستبدله	عند الحاجة تصحيح قصير وسلك خامل جديد
انكسر الجهاز المتحرك أو فُقد	طبعة/مسح جديد	حتى التسليم: إصلاح الجهاز الحالي أو جبيرة مؤقتة

خطأ شائع

إعادة لصق النقطة المنفصلة دون تصحيح السن المنزاحة أولًا. بهذا تجعل الانتكاس دائمًا. تحقق من الوضع أولًا، ثم الصق.

الفصل 8

الانتكاس: التعرّف والتدخل

التقط الانتكاس البسيط مبكرًا، وأعد تخطيط الكبير.

العلامات المبكرة للانتكاس

افحصها في المراجعة

- [ ] يقول المريض إن الجهاز المتحرك «يضغط» أو لا يستقر في مكانه.
- [ ] دوران خفيف أو انزياح نقطة التماس في القواطع.
- [ ] انفتاح فراغ في منطقة الخلع أو الدياستيما.
- [ ] زيادة التراكب الأفقي أو التراكب العمودي.
- [ ] تغيّر في الخط المتوسط.
- [ ] في المنطقة الموسّعة يتحول التماس الخلفي إلى وضع حدبة على حدبة.
- [ ] في العضة المفتوحة: فقدان التماس الأمامي.

درجة الانتكاس	مثال	النهج
خفيف	دوران خفيف، فراغ صغير؛ الجهاز يستقر بصعوبة.	زِد مدة الارتداء. ومراجعة جديدة خلال وقت قصير.
متوسط	الجهاز لا يستقر؛ انزياح واضح في عدة أسنان.	توثيق جديد، وتصحيح محدود (علاج ثابت قصير أو سلسلة جبائر شفافة) وتثبيت جديد.
واضح	تغيّرت علاقة العضة، وعاد التراكب الأفقي/العمودي.	إعادة تشخيص كاملة: لماذا عاد؟ النمو، العادة، قيد هيكلي؟

هل زال سبب الانتكاس؟ (العادة، النمو، الحالة حول السنية)

↓

نعم ← تصحيح + خطة تثبيت أقوى.

لا ← عالج السبب أولًا. التصحيح الذي يُجرى مع بقاء السبب سيعود من جديد.

الحديث مع المريض

اشرح الانتكاس دون لوم: «الأسنان تميل إلى الحركة، ولهذا نستخدم التثبيت. التغير الآن بهذا الحجم، وهكذا يمكننا علاجه.» وسلّم الخيارات ومسؤولية الارتداء كتابيًا.

خطأ شائع

اعتبار ازدحام القواطع السفلية لدى مريض الصنف الثالث في طور النمو «نقصًا في التعاون». قد يكون نموًا متأخرًا للفك السفلي. أعد تقييم علاقة العضة والجانبية (البروفايل).

الفصل 9

قائمة التحقق عند تسليم الجهاز

يوم الإزالة، أشّر على هذه القائمة بجانب المريض.

قبل الإزالة

- [ ] تم التحقق من أهداف الإنهاء (الإطباق، توازي الجذور، العزم، الخط المتوسط).
- [ ] تم تقييم العادات ووضع اللسان.
- [ ] شرحت للمريض مسبقًا نوع التثبيت ومدته، ووافق عليهما.
- [ ] أُخذت الطبعة/المسح، والجهاز المتحرك جاهز.
- [ ] اكتمل التوثيق الختامي (صور، نموذج/مسح، وصورة بانورامية عند الحاجة).

تسليم المثبّت اللساني الثابت

- [ ] السلك خامل: لا يضغط على الأسنان ولا يلامس اللثة.
- [ ] الكمبوزيت يحيط بكل نقطة تمامًا، ولا يوجد فائض.
- [ ] خيط الأسنان يمر في المناطق الملاصقة.
- [ ] عند الإطباق لا يتلامس الكمبوزيت ولا السلك.
- [ ] أريت المريض طريقة التنظيف بممرر الخيط.

تسليم الجهاز المتحرك

- [ ] الجهاز يستقر دون ضغط ويثبت جيدًا.
- [ ] لا توجد حواف حادة، واللثة والحليمات غير متهيجة.
- [ ] أظهر المريض أمام المرآة طريقة الوضع والنزع.
- [ ] سلّمت مدة الارتداء كتابيًا.
- [ ] شرحت التنظيف واستخدام علبة الحفظ.
- [ ] سلّمت نشرة المريض (الفصل 10).
- [ ] حدّدت موعد المراجعة الأولى.

الفصل 10

نشرة المريض (نص للتسليم)

يمكنك طباعة هذه الصفحة وتسليمها لمريضك.

عن جهاز التثبيت الخاص بك

انتهى علاجك. وإلى أن تعتاد أسنانك على وضعها الجديد، فإنها تميل إلى الحركة نحو وضعها السابق. وجهاز التثبيت يمنع هذه الحركة. التثبيت جزء من العلاج، والحفاظ على النتيجة يعتمد عليك إلى حد كبير.

السلك الثابت (خلف الأسنان)

- نظّف المنطقة تحت السلك يوميًا بممرر الخيط.
- لا تقضم الأطعمة القاسية (المكسرات بقشرها، الحلوى الصلبة، الثلج) بأسنانك الأمامية.
- إذا شعرت بانفصال السلك أو كسره أو وخزه، احجز موعدًا في أقرب وقت.
- لا تحاول ثني السلك أو شدّه بنفسك.
- احضر زيارات المراجعة حتى لو بدا السلك سليمًا.

الجهاز المتحرك (الجبيرة)

- ارتدِه للمدة التي حددها لك طبيبك.
- انزعه عند الأكل واحفظه في علبته؛ ولا تلفّه في منديل.
- نظّفه بفرشاة ناعمة وماء بارد/فاتر. الماء الساخن يشوّهه.
- إذا كانت الجبيرة تضغط فهذه علامة على أن الأسنان تتحرك: ارتدِها بانتظام أكبر وأخبر طبيبك.
- إذا انكسرت الجبيرة أو فُقدت، احجز موعدًا فورًا.

جدول الارتداء الخاص بك

جهاز الفك العلوي

جهاز الفك السفلي

مدة الارتداء (حاليًا)

موعد زيارة المراجعة الأولى

مادة لأغراض تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الاختصاصي.

الخطوة التالية

يبدأ التثبيت بجودة الإنهاء. افتح الآن فصل **الوحدة 08 · الإنهاء والثبات**، وراجع فحوص الإنهاء قبل مريضك التالي الذي ينتظر الإزالة. ثم تابع مع **الدليل 3 · أطلس الأنابيب التقويمية**.